Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AUFKLÄRUNGS- UND EINWILLIGUNGSBOGEN

Temporal Lift

Anhebung der äußeren Augenbraue und des Augenwinkels über die Schläfen (laterales Brauenlifting)

Liebe Patientin, lieber Patient, dieser Bogen soll Ihnen in **einfacher und verständlicher Sprache** erklären, was Sie über den Ihnen empfohlenen Eingriff wissen sollten. Er soll Ihnen keine Angst machen, sondern Ihnen helfen, Ihre Entscheidung **frei und gut informiert** zu treffen.

Bitte lesen Sie diesen Bogen in Ruhe durch. Fragen Sie Ihren Arzt nach allem, was Sie nicht verstehen. Ihr Arzt wird Ihnen außerdem mündlich die Risiken erläutern, die speziell in Ihrer Situation bestehen. Ob Sie Ihre Einwilligung geben oder nicht, ist allein Ihr Recht.

ANGABEN ZU PATIENT/IN UND EINGRIFF

Vor- und Nachname: _____ Geburtsdatum: _____

Reisepass- / Ausweisnummer: _____ Akten- / Protokollnummer: _____

Telefon: _____ Datum der Aufklärung: _____

Geplantes Datum des Eingriffs: _____

Bogen erstmals an Patient/in übermittelt (Datum / E-Mail, WhatsApp, persönlich): _____

Durchführender und aufklärender Arzt: **Op. Dr. Murat Ayata**

Krankenhaus / Einrichtung, in der der Eingriff durchgeführt wird: _____

Seite: ☐ Rechts ☐ Links ☐ Beidseitig

Schnittführung: ☐ Innerhalb der behaarten Kopfhaut (Schläfe) ☐ Am Haaransatz ☐ Wird während der Operation festgelegt _____

Fixierungsmethode: ☐ Dauerhafte Nähte ☐ Resorbierbares Fixierungssystem ☐ Sonstiges _____

Gleichzeitig durchzuführende Eingriffe: ☐ Oberlidstraffung (gesonderte Einwilligung) ☐ Eigenfettinjektion ☐ Keine _____

Beschwerden und Erwartungen des Patienten / der Patientin: _____

1 Ihre Erkrankung und das Ziel des Eingriffs

Mit zunehmendem Alter erschlaffen die Gewebe von Stirn und Schläfen; insbesondere das **äußere Ende der Augenbraue** und der **äußere Augenwinkel** sinken nach unten. Dies kann zu einem müden, traurigen oder schweren Blick führen, einen Hautüberschuss am Oberlid vortäuschen und Fältchen am Augenwinkel verursachen. Bei manchen Menschen ist diese Form auch angeboren.

Das Temporal Lift ist eine Operation, bei der über kleine Schnitte in der behaarten Kopfhaut der Schläfen **der äußere Teil der Augenbraue und der Augenwinkel nach oben und hinten angehoben werden**. Ziel ist ein **frischerer, offenerer Blick**, der zu Ihrem Gesicht passt. Allein korrigiert der Eingriff weder den inneren Teil der Augenbraue noch die gesamte Stirn oder einen Hautüberschuss am Augenlid; bei Bedarf wird er mit anderen Eingriffen kombiniert.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Wie wird der Eingriff durchgeführt?

Die Operation erfolgt in der Regel in Vollnarkose oder in Sedierung mit örtlicher Betäubung im Operationssaal. Vorab wird die Position Ihrer Augenbrauen und Augenwinkel im Stehen und Sitzen beurteilt, es werden Fotos angefertigt und die Richtung der Anhebung wird gemeinsam mit Ihnen angezeichnet.

1. **Schnitt:** Auf jeder Seite werden innerhalb der behaarten Kopfhaut der Schläfe oder am Haaransatz Schnitte von etwa 3–5 cm Länge gesetzt. Die Haare werden nicht rasiert oder es wird nur ein sehr schmaler Streifen entlang des Schnitts gekürzt.
2. **Lösen der Gewebe:** Der Chirurg arbeitet in der tiefen Schicht der Schläfenregion so, dass der zur Stirn ziehende Ast des Gesichtsnervs geschont wird. Das Bindegewebe um die äußere Augenbraue und den Augenwinkel wird behutsam gelöst, sodass es verschoben werden kann.
3. **Anheben und Fixieren:** Die gelösten Gewebe werden in der geplanten Richtung nach oben und hinten gezogen und mit **dauerhaften Nähten** oder **resorbierbaren Fixierungssystemen** an der festen Gewebeschicht der Schläfe befestigt. Das Gleichgewicht zwischen beiden Seiten wird überprüft.
4. **Wundverschluss:** Bei Bedarf wird ein kleiner Überschuss an Kopfhaut entfernt. Die Schnitte werden mit Klammern oder Nähten verschlossen, manchmal wird eine dünne Drainage eingelegt und ein leichter Kopfverband angelegt.

Soll gleichzeitig eine Oberlidstraffung (Blepharoplastik) oder ein anderer Eingriff durchgeführt werden, wird dafür ein **gesonderter Aufklärungs- und Einwilligungsbogen** unterschrieben.

BETÄUBUNG (ANÄSTHESIE)	VORAUSSICHTLICHE DAUER	KRANKENHAUSAUFENTHALT / ENTLASSUNG
Vollnarkose oder Sedierung + örtliche Betäubung	Etwa 1–2 Stunden	In der Regel ambulant oder eine Nacht im Krankenhaus

3 Erwarteter Nutzen und Erfolgsaussichten

- Ein frischerer, offenerer und jüngerer Blick durch die Anhebung der äußeren Augenbraue und des Augenwinkels
- Weniger Schwere und scheinbarer Hautüberschuss am äußeren Oberlid
- Keine sichtbare Narbe im Gesicht, da die Schnitte im Haar verborgen liegen

Die meisten geeignet ausgewählten Patientinnen und Patienten sind mit dem Ergebnis zufrieden. In den ersten Wochen können die Augenbrauen etwas höher wirken als geplant; dies gleicht sich aus, während sich das Gewebe setzt. Das endgültige Ergebnis zeigt sich nach **3–6 Monaten**. Die angehobenen Gewebe können mit der Zeit durch Alterung und Schwerkraft wieder etwas absinken; wie lange die Wirkung anhält, ist individuell verschieden und beträgt in der Regel **mehrere Jahre**. Bei etwa **5–10 von 100** Patienten kann wegen einer Asymmetrie oder einer frühen Lockerung eine Korrektur erforderlich werden.

4 Andere Behandlungsmöglichkeiten

- **Verzicht auf die Operation:** Da es sich um einen ästhetischen Eingriff handelt, können Sie sich jederzeit auch dagegen entscheiden.
- **Brauenanhebung mit Botulinumtoxin:** Kann die äußere Augenbraue um einige Millimeter anheben, vorübergehend (3–4 Monate).
- **Fadenlifting-Verfahren:** Werden mit weniger Schnitten durchgeführt, die Wirkung ist jedoch meist begrenzter und kürzer anhaltend.
- **Unterstützung von Schläfe/Augenbraue mit Fillern:** Kann bei einem durch Volumenverlust bedingten Absinken eine vorübergehende Verbesserung bewirken; Filler haben eigene Risiken, z. B. den Verschluss eines Blutgefäßes.
- **Andere Brauenlifting-Operationen:** Sind auch die gesamte Stirn und der innere Teil der Augenbraue abgesunken, können ein endoskopisches Stirnlifting oder Verfahren mit einem Schnitt oberhalb der Augenbraue oder am Haaransatz besser geeignet sein.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Alleinige Oberlidstraffung:** Kann ausreichen, wenn das Hauptproblem ein Hautüberschuss am Lid ist; eine tief stehende Augenbraue wird dadurch nicht korrigiert.

5 Was geschieht, wenn der Eingriff nicht durchgeführt wird?

Wird die Operation nicht durchgeführt, bleibt das derzeitige Erscheinungsbild Ihrer Augenbrauen und Augenwinkel bestehen und die natürliche Alterung schreitet fort. Eine Gefahr für Ihre Gesundheit besteht dadurch nicht.

Sie haben das Recht, den empfohlenen Eingriff abzulehnen, ihn zu verschieben oder eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Diese Entscheidung hat keinerlei Einfluss auf andere medizinische Leistungen, die Ihnen angeboten werden. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen; bitte beachten Sie jedoch, dass es nach Beginn eines Eingriffs Phasen geben kann, in denen ein Abbruch medizinisch nicht vertretbar wäre.

6 Vorbereitung auf den Eingriff

- Vor der Operation werden Blutuntersuchungen und bei Bedarf weitere Untersuchungen durchgeführt; ist eine Vollnarkose geplant, werden Sie von der Narkoseärztin bzw. dem Narkosearzt untersucht.
- In den **6–8 Stunden** vor der Operation dürfen Sie nichts essen und nichts trinken (bitte halten Sie sich an die Anweisungen der Narkoseärztin bzw. des Narkosearztes).
- Waschen Sie Ihre Haare am Abend vor oder am Morgen der Operation; verwenden Sie am Operationstag kein Haarspray, kein Gel, kein Make-up und keine Kontaktlinsen. Ein Haarschnitt ist in der Regel nicht notwendig.
- Teilen Sie Ihrem Arzt mit, wenn Sie in den letzten **3–4 Monaten** Botulinumtoxin im Stirn- oder Augenbrauenbereich erhalten haben; dies kann die Planung beeinflussen.
- Es wird empfohlen, dass am ersten Tag nach der Operation eine Begleitperson bei Ihnen bleibt.
- Teilen Sie Ihrem Arzt **alle Medikamente** mit, die Sie einnehmen (einschließlich Blutverdünnern, Aspirin, Schmerzmitteln, Medikamenten zur Gewichtsabnahme und Hormonpräparaten), sowie alle **pflanzlichen Mittel und Nahrungsergänzungsmittel** (z. B. Omega-3, Vitamin E, Ginkgo, Knoblauch, Ginseng, Fischöl). Setzen Sie kein Medikament eigenmächtig ohne ärztlichen Rat ab.
- Informieren Sie uns unbedingt über **Allergien**, Blutungs- oder Gerinnungsstörungen, Herz- und Lungenerkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen, frühere Operationen sowie über Probleme, die Sie bei früheren Narkosen hatten.
- Wenn Sie möglicherweise schwanger sind oder stillen, teilen Sie uns dies bitte vor dem Eingriff mit.
- Rauchen und Nikotinprodukte beeinträchtigen die Wundheilung erheblich. Hören Sie nach Möglichkeit mindestens 2–4 Wochen vor dem Eingriff damit auf und rauchen Sie während der Heilungsphase nicht.

7 Heilungsverlauf: Was Sie erwartet

Erste 48 Stunden	Sie spüren ein Spannungsgefühl, leichte Kopfschmerzen und eine Schwellung an Schläfen und Stirn; die Schmerzen sind meist gering und lassen sich mit Schmerzmitteln gut behandeln. Die Schwellung kann sich in Richtung Augen verlagern; Blutergüsse treten, **falls sie auftreten**, an den Augenlidern auf. Schlafen mit erhöhtem Kopf und kühlende Umschläge helfen, die Schwellung zu verringern. Wurde eine Drainage eingelegt, wird sie in der Regel am nächsten Tag entfernt.
1. Woche	Ab dem **2.–3. Tag** können Sie Ihre Haare in der Regel vorsichtig mit einem milden Shampoo waschen. Augenbrauen und Augenwinkel können in dieser Phase höher und straffer wirken als geplant. Die meisten Patienten nehmen ihre Alltagsaktivitäten und Schreibtischarbeit innerhalb von 5–7 Tagen wieder auf.
Tag 7–14	Klammern oder Fäden werden entfernt. Taubheitsgefühl, Juckreiz und Empfindlichkeit entlang des Schnitts an den Schläfen können weiter bestehen.
Woche 2–6	Die Schwellung klingt weitgehend ab und der Blick wirkt natürlicher. Anstrengender Sport sowie enge Stirnbänder/Helme, die auf die Schläfen drücken, sollten mindestens **3–4**

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

	Wochen lang vermieden werden, Haarefärben und ähnliche chemische Behandlungen mindestens **4–6 Wochen** lang; verwenden Sie den Föhn auf lauwarmer Stufe.
Monat 3–6	Das Gewebe setzt sich und das endgültige Erscheinungsbild zeigt sich. Veränderungen des Gefühls in der Kopfhaut bilden sich weitgehend zurück; die Narbe verblasst.

8 Mögliche Risiken und Komplikationen

Wie jeder medizinische Eingriff ist auch dieser Eingriff mit gewissen Risiken verbunden. Im Folgenden sind **zu erwartende vorübergehende Begleiterscheinungen** und **Komplikationen** getrennt aufgeführt und nach ihrer Häufigkeit geordnet. Die angegebenen Zahlen sind **ungefähre** Werte aus der medizinischen Fachliteratur; Ihr persönliches Risiko kann je nach Alter, allgemeinem Gesundheitszustand, Rauchen und früheren Operationen niedriger oder höher sein.

Die allermeisten Komplikationen sind **vorübergehend** und bessern sich bei angemessener Behandlung. Aufgeführt sind auch sehr seltene, aber schwerwiegende Ereignisse; dass sie hier stehen, bedeutet nicht, dass sie bei Ihnen auftreten werden, doch Sie sollten sie kennen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

Zu erwartende, vorübergehende Begleiterscheinungen (keine Komplikationen – ein normaler Teil der Heilung)

- Spannungsgefühl, Druckgefühl und leichte Kopfschmerzen an Schläfen und Stirn
- Schwellung an der Stirn und um die Augen; Blutergüsse klingen, **falls sie auftreten**, innerhalb von 1–2 Wochen ab
- In den ersten Wochen höher als geplant wirkende Augenbrauen oder ein erstaunter Gesichtsausdruck
- Taubheitsgefühl, Juckreiz oder Kribbeln an Schläfen und Kopfhaut
- Empfindlichkeit und Verhärtung entlang des Schnitts

Häufige Beschwerden (meist vorübergehend oder mit Behandlung rückläufig)

- **Leichte Asymmetrie** — Augenbrauen sind von Natur aus nicht vollkommen symmetrisch; nach der Operation können geringe Unterschiede zwischen beiden Seiten bestehen bleiben oder während der Heilung auftreten.
- **Ausdünnung der Haare entlang des Schnitts** — Ein vorübergehender Haarausfall um den Schnitt (Schockhaarausfall) ist häufig; die Haare wachsen in der Regel innerhalb von **2–4 Monaten** nach. Der Schnitt bleibt als feine, von Haaren bedeckte Linie zurück.
- **Länger anhaltendes Taubheitsgefühl und Juckreiz** — Ein verändertes Gefühl in der Kopfhaut kann mehrere Monate anhalten; Juckreiz während der Heilung ist normal.
- **Teilweise Lockerung** — Ein gewisses Absinken der angehobenen Gewebe in den ersten Monaten ist zu erwarten; deshalb kann bei der Operation bewusst etwas stärker angehoben werden.

Gelegentliche Beschwerden

- **Vorübergehende Schwäche beim Anheben der Augenbraue (Stirnast des Gesichtsnervs)** — Bei etwa **1–3 von 100** Patienten kann auf einer Seite eine vorübergehende Schwäche beim Anheben der Augenbraue oder beim Runzeln der Stirn auftreten. Ursache ist meist eine Dehnung des Nervs oder eine Schwellung; die Schwäche bildet sich innerhalb von **einigen Wochen bis einigen Monaten** von selbst zurück.
- **Dauerhafter Haarverlust oder breite Narbe** — Entlang des Schnitts kann selten eine dauerhaft haarlose Stelle oder eine verbreiterte Narbe entstehen; insbesondere Narben am Haaransatz können auffälliger sein. Bei Bedarf kann dies durch eine Narbenkorrektur oder eine Haartransplantation verbessert werden.
- **Hämatom (Blutansammlung)** — Bei etwa **1–2 von 100** Patienten kann sich Blut in der Schläfenregion ansammeln; es muss eventuell mit einer Nadel oder durch einen kleinen Eingriff entleert werden.
- **Infektion** — Tritt bei **weniger als 1 von 100** Patienten auf. Sie heilt meist mit Antibiotika ab; selten ist eine Eiterentleerung oder die Entfernung einer Fixierungsnaht erforderlich.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Überkorrektur: „erstaunter" oder zu stark schräg gestellter („Fox Eye") Blick** — Die äußere Augenbraue oder der Augenwinkel können stärker angehoben wirken als gewünscht. Dies gleicht sich meist in den ersten Wochen aus, während sich das Gewebe setzt; bleibt es bestehen, kann eine Korrektur erforderlich werden.
- **Frühes Absinken oder unzureichende Wirkung** — Durch eine Lockerung der Fixierung oder aufgrund der Gewebebeschaffenheit kann die Augenbraue früher als erwartet absinken; eine erneute Anhebung kann erforderlich werden.
- **Probleme durch das Fixierungsmaterial** — Eine dauerhafte Naht oder ein Fixierungssystem kann unter der Haut tastbar sein, druckempfindlich sein oder selten durch die Haut nach außen treten; in diesem Fall muss es eventuell entfernt werden.

Seltene oder sehr seltene, aber möglicherweise schwerwiegende Komplikationen

- **Dauerhafte Nervenschädigung** — Eine dauerhafte Schädigung des Nervenastes, der den Brauenhebermuskel versorgt, ist **sehr selten** (weit weniger als 1 von 100 Patienten). In diesem Fall hebt sich die Augenbraue auf dieser Seite nicht mehr und die Stirn lässt sich nicht mehr runzeln; zur Verringerung der Asymmetrie können Botulinumtoxin auf der Gegenseite oder eine weitere Operation erforderlich werden.
- **Dauerhaftes Taubheitsgefühl oder chronische Schmerzen** — Sehr selten können ein dauerhafter Gefühlsverlust der Kopfhaut, länger anhaltende Schmerzen durch eine Nerveneinklemmung oder Kopfschmerzen auftreten; eine weitere Behandlung kann erforderlich werden.
- **Durchblutungsstörung der Haut** — Insbesondere bei Rauchern können Wundheilungsstörungen an den Schnitträndern auftreten, die zu einer breiteren Narbe und zu Haarverlust führen.
- **Erschwerter Lidschluss und trockenes Auge** — Wurde in derselben Sitzung eine Oberlidstraffung durchgeführt, können selten Schwierigkeiten beim vollständigen Schließen des Auges und Beschwerden eines trockenen Auges auftreten; diese sind meist vorübergehend.
- **Psychische Unzufriedenheit** — Trotz eines technisch gelungenen Ergebnisses kann es schwerfallen, sich an das neue Aussehen zu gewöhnen. Ein offenes Gespräch über die Erwartungen vor der Operation verringert dieses Risiko.

Allgemeine Risiken jedes operativen / medizinischen Eingriffs

- **Narkoserisiken:** Wird eine Vollnarkose oder Sedierung (Dämmerschlaf) durchgeführt, erläutert Ihnen der Narkosearzt deren Risiken (Übelkeit, Halsschmerzen, Zahnschäden, allergische Reaktion und sehr selten Herz- oder Lungenprobleme) gesondert, und Ihre Einwilligung wird auf einem **separaten Narkose-Aufklärungsbogen** eingeholt.
- **Blutung und Bluttransfusion:** Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten erforderlich. Bei einer schweren Blutung können Blut oder Blutprodukte notwendig werden; diese bergen eigene, sehr seltene Risiken (z. B. Allergie oder Infektion).
- **Infektion:** Eine Wundinfektion nach der Operation wird in der Regel mit Antibiotika behandelt; selten kann eine Drainage (Ableiten des Eiters) notwendig sein.
- **Blutgerinnsel in den Beinvenen (Thrombose) und in der Lunge (Lungenembolie):** Bei kurzen Operationen im Kopf-Hals-Bereich sehr selten. Frühes Aufstehen und Gehen senkt das Risiko. Hormonpräparate, Rauchen, starkes Übergewicht und frühere Blutgerinnsel erhöhen das Risiko.
- **Medikamentenallergie:** Auf die verwendeten Medikamente, Desinfektionsmittel, Pflaster oder Nahtmaterialien kann eine allergische Reaktion auftreten.
- **Narbenbildung und Heilungsstörungen:** Wie Narben verheilen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich; sehr selten kann sich eine verdickte (hypertrophe) Narbe oder ein Keloid bilden.
- **Lebensgefahr:** Todesfälle bei geplanten Operationen im Kopf-Hals-Bereich sind heute äußerst selten; dennoch ist kein operativer Eingriff völlig frei von Risiken. Eine schwere Komplikation kann eine Behandlung auf der Intensivstation erforderlich machen und zu einer bleibenden Behinderung führen.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Diese Aufstellung umfasst nicht jede denkbare Komplikation; andere unvorhersehbare und sehr seltene Ereignisse können auftreten. Tritt eine Komplikation auf, plant Ihr Arzt die notwendige Behandlung und Nachsorge; dies kann eine zusätzliche Behandlung, Medikamente, Eingriffe oder eine erneute Operation erfordern.

9 Wann Sie sich sofort bei uns melden sollten

- **Rasch zunehmende, pralle und schmerzhafte Schwellung** an Schläfe oder Stirn
- **Nicht stillbare Blutung** aus den Schnitten
- **Fieber über 38,5 °C**, zunehmende Rötung, Schmerzen, Überwärmung oder Eiter an den Schnittstellen
- **Starke Kopfschmerzen**, die auf Schmerzmittel nicht ansprechen, Erbrechen oder Nackensteifigkeit
- **Verschwommenes Sehen oder Doppelbilder**, Augenschmerzen oder Unfähigkeit, das Auge zu schließen
- Dunkelfärbung, violett-schwarze Verfärbung der Haut oder Aufgehen der Wunde

Wenn eines dieser Anzeichen auftritt, rufen Sie unverzüglich Ihren Arzt an: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Wenn Sie uns nicht erreichen, suchen Sie die nächste Notaufnahme auf oder wählen Sie die 112 (Notrufnummer in der Türkei und in ganz Europa).

10 Hinweise zu Medikamenten und zum Alltag

- Schlafen Sie in den ersten 1–2 Wochen auf dem Rücken mit erhöhtem Kopf; vermeiden Sie es, auf dem Bauch oder auf den Schläfen zu liegen.
- Reiben Sie in den ersten 3–4 Wochen nicht an Augenbrauen oder Stirn, massieren Sie nicht die Schläfen und vermeiden Sie Bewegungen, die das Gesicht nach unten ziehen.
- Verschieben Sie chemische und wärmebasierte Behandlungen wie Haarefärben, Dauerwelle und Glätteisen um mindestens **4–6 Wochen**. Verwenden Sie den Föhn auf lauwarmer Stufe.
- Vermeiden Sie in den ersten 3–4 Wochen anstrengenden Sport, Bücken, schweres Heben, Sauna und Hamam (türkisches Bad).
- Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, ist ein Flug in der Regel nach der ersten Kontrolluntersuchung, meist ab dem 3.–5. Tag, unbedenklich.
- Nehmen Sie die Ihnen verordneten Medikamente (Antibiotika, Schmerzmittel usw.) in der empfohlenen Dosierung und für die empfohlene Dauer ein. Nehmen Sie Aspirin oder ähnliche Medikamente, die Blutungen verstärken können, nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.
- Trinken Sie nach der Operation bei Flügen oder Reisen von mehr als 4 Stunden reichlich Wasser, bewegen Sie sich regelmäßig und tragen Sie, falls empfohlen, Kompressionsstrümpfe; dies senkt das Risiko von Blutgerinnseln in den Beinen.
- Während der Heilungsphase wird empfohlen, keinen Alkohol zu trinken und auf Rauchen und Nikotinprodukte zu verzichten.
- Bitte nehmen Sie alle Kontrolltermine wahr. Wenn Sie aus dem Ausland angereist sind, kann die Nachsorge nach Ihrer Rückkehr per Online-Sprechstunde und Fotos/Videos fortgeführt werden; falls Sie einen Arzt vor Ort aufsuchen müssen, erhalten Sie einen schriftlichen Operationsbericht und unsere Empfehlungen.

11 Unerwartete Befunde während des Eingriffs, Gewebeproben und Blutprodukte

Ergibt sich während des Eingriffs eine unvorhergesehene Situation, hält sich Ihr Arzt an den Umfang des Eingriffs, in den Sie mit diesem Bogen eingewilligt haben. **Sofern keine Lebensgefahr und keine Gefahr eines schweren Organschadens besteht**, wird kein zusätzlicher Eingriff vorgenommen, in den Sie nicht eingewilligt haben; in diesem Fall wird der Eingriff an einem sicheren Punkt beendet, und Sie werden anschließend informiert, damit die Entscheidung gemeinsam mit Ihnen getroffen werden kann. Besteht Lebensgefahr, wird die Notfallbehandlung durchgeführt, die zum Schutz Ihres Lebens oder des Organs erforderlich ist.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Während des Eingriffs entnommenes Gewebe wird, wenn nötig, zur Sicherung der Diagnose zur **feingeweblichen (pathologischen) Untersuchung** eingesandt. Je nach Ergebnis kann eine weitere Behandlung oder Nachsorge erforderlich sein.

Eine Bluttransfusion ist bei diesen Eingriffen nur sehr selten notwendig und wird nur verabreicht, wenn sie lebenswichtig ist. Wenn Sie Blut oder Blutprodukte ablehnen (zum Beispiel aus religiösen Gründen), müssen Sie uns dies vor dem Eingriff mitteilen; die möglichen Folgen dieser Entscheidung werden gesondert mit Ihnen besprochen und unter „Informationen speziell für Sie“ festgehalten.

12 Fotos, Bildaufnahmen und Ihre personenbezogenen Daten

Vor und nach dem Eingriff können zur Planung, Verlaufskontrolle und Beurteilung des Ergebnisses **Fotos/Videos** angefertigt werden. Diese Aufnahmen sind Teil Ihrer Krankenakte und werden vertraulich behandelt. Ihre Aufnahmen werden **niemals für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit oder soziale Medien verwendet.**

Für jeden anderen Zweck dürfen Ihre Aufnahmen **nur mit Ihrer gesonderten und ausdrücklichen Erlaubnis** verwendet werden. Eine Ablehnung hat keinerlei Einfluss auf Ihre Behandlung, und Sie können Ihre Erlaubnis jederzeit widerrufen:

- ☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen **ausschließlich für die medizinische Dokumentation und die Verlaufskontrolle der Behandlung** verwendet werden.
- ☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich nicht erkennbar bin** (Gesicht/Augenpartie abgedeckt).
- ☐ Ich erlaube die Verwendung meiner Aufnahmen für wissenschaftliche Veröffentlichungen und die ärztliche Aus- und Weiterbildung **in einer Form, in der ich erkennbar sein kann**.
- ☐ Ich **erlaube keine** Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken / Ausbildungszwecken.

Ihre personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden nach dem türkischen Gesetz Nr. 6698 zum Schutz personenbezogener Daten (KVKK) und den einschlägigen gesundheitsrechtlichen Vorschriften zu Zwecken der Diagnose, der Behandlung und der Erfüllung gesetzlicher Pflichten von Personen verarbeitet, die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Datenschutzhinweisen.

13 Informationen und Anmerkungen speziell für Sie (vom Arzt auszufüllen)

Patientenspezifische zusätzliche Risiken (Begleiterkrankungen, Medikamente, frühere Operationen), Einzelheiten der Planung, Erwartungen der Patientin / des Patienten, gestellte Fragen und gegebene Antworten. Gibt es nichts zu ergänzen, „keine“ eintragen.

14 Erklärung der Patientin / des Patienten

- ☐ Ich habe diesen Bogen in meiner Sprache gelesen und verstanden. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit, konnte Fragen stellen und habe zufriedenstellende Antworten erhalten.
- ☐ Meine Erkrankung, das Ziel des empfohlenen Eingriffs, wie, von wem und wo er durchgeführt wird, seine voraussichtliche Dauer, der erwartete Nutzen, die Erfolgsaussichten, die Alternativen und die möglichen Folgen, wenn er nicht durchgeführt wird, wurden mir mündlich und schriftlich erklärt.
- ☐ Die häufigen und die möglicherweise schwerwiegenden Risiken sowie die möglichen Folgen dieser Komplikationen (einschließlich der Möglichkeit, dass eine weitere Behandlung oder ein erneuter Eingriff bzw. eine erneute Operation notwendig wird) wurden mir erklärt. Mir ist bewusst, dass das Ergebnis eines medizinischen Eingriffs **nicht zu 100 % garantiert werden kann**.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Ich habe zutreffende und vollständige Angaben zu meinem Gesundheitszustand, meinen Medikamenten, meinen Allergien und früheren Erkrankungen gemacht. Mir ist bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben die Risiken erhöhen können.
- ☐ Mir ist bewusst, dass die Befolgung der Anweisungen vor und nach dem Eingriff zum Ergebnis beiträgt und dass die Wahrnehmung der Kontrolltermine wichtig ist.
- ☐ Ich weiß, dass ich meine Einwilligung jederzeit vor Beginn des Eingriffs widerrufen kann. Mir ist bewusst, dass meine Unterschrift unter diesen Bogen den Arzt nicht von seiner Sorgfaltspflicht entbindet.
- ☐ Ich treffe diese Entscheidung aus freiem Willen und ohne Druck von irgendeiner Seite.
- ☐ Ich habe verstanden, dass ein Temporal Lift den äußeren Teil der Augenbraue und den Augenwinkel anhebt und allein weder die gesamte Stirn noch den inneren Teil der Augenbraue oder einen Hautüberschuss am Augenlid korrigiert.
- ☐ Ich habe verstanden, dass die Augenbrauen in den ersten Wochen höher und straffer wirken können, dass die angehobenen Gewebe mit der Zeit wieder etwas absinken können und dass die Wirkung nicht dauerhaft ist.
- ☐ Mir ist bewusst, dass dieser Eingriff **ästhetischer Natur** ist, dass er medizinisch nicht notwendig ist und dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, ihn nicht durchführen zu lassen. Ich habe meine Erwartungen mit meinem Arzt besprochen, und das realistisch erreichbare Ergebnis wurde mir erklärt.
- ☐ Mir ist bewusst, dass weder eine vollkommene Symmetrie noch eine exakte Nachbildung des Aussehens auf einem Foto garantiert werden kann, dass das endgültige Ergebnis davon abhängt, wie mein Gewebe heilt, und dass in manchen Fällen ein Korrektureingriff notwendig sein kann.

- ☐ **Ich ERTEILE MEINE EINWILLIGUNG zu dem oben beschriebenen Eingriff.**
- ☐ **Den oben beschriebenen Eingriff LEHNE ICH AB. Die möglichen Folgen der Ablehnung wurden mir erklärt.**

Wir empfehlen, dass die Patientin / der Patient handschriftlich ergänzt: „Ich habe diesen Bogen gelesen und verstanden und willige ein.“

15 Unterschriften

	VOR- UND NACHNAME	UNTERSCHRIFT	DATUM / UHRZEIT
Patient/in			
Gesetzliche/r Vertreter/in (Elternteil / Vormund) – Verhältnis zum Patienten:			
Aufklärender und durchführender Arzt			
Dolmetscher/in (falls erforderlich) – Sprache:			
Zeuge/Zeugin (falls erforderlich)			

Erklärung der Dolmetscherin / des Dolmetschers: Ich habe diesen Bogen und die mündlichen Erläuterungen des Arztes der Patientin / dem Patienten bzw. der gesetzlichen Vertretung vollständig und korrekt in eine für sie verständliche Sprache übersetzt.

Privatpraxis Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Türkei
Tel.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN UNTER 18 JAHREN ODER MIT EINGESCHRÄNKTER EINWILLIGUNGSFÄHIGKEIT

Bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren wird die Einwilligung von einem **Elternteil oder dem gesetzlichen Vormund** erteilt. Das Kind wird seinem Alter und seiner Reife entsprechend aufgeklärt, und seine Meinung wird eingeholt. Bei nicht einwilligungsfähigen Patientinnen und Patienten erteilt die gesetzliche Vertretung die Einwilligung.

☐ Sofern wir das Sorgerecht gemeinsam ausüben, erkläre ich, dass der andere Elternteil über diesen Eingriff informiert ist und ihm zustimmt.

☐ Ich erkläre, dass keine gerichtliche Entscheidung und kein Streit über das Sorgerecht / die Vormundschaft besteht (falls doch, wurde dem Arzt das entsprechende Dokument vorgelegt).

Das Kind wurde altersgerecht aufgeklärt; Meinung des Kindes: _____

Dieser Bogen wurde in zwei Exemplaren ausgefertigt: Ein Exemplar verbleibt in der Patientenakte, eines erhält die Patientin / der Patient bzw. die gesetzliche Vertretung.

WIDERRUF DER EINWILLIGUNG (NUR AUSFÜLLEN, WENN SIE SICH ANDERS ENTSCHEIDEN)

Ich widerrufe die oben erteilte Einwilligung. Die möglichen Folgen des Widerrufs wurden mir erklärt.

Name, Unterschrift, Datum und Uhrzeit der widerrufenden Person (Patient/in bzw. Vertreter/in): _____

Dieser Bogen wurde in Übereinstimmung mit der türkischen Patientenrechteverordnung und den Grundsätzen der Türkischen Ärztekammer zur Aufklärung und Einwilligung erstellt. Er ergänzt das mündliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt, ersetzt es aber nicht.